جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) *

طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : ياسر رجب خلف الله معوض
المحافظة : الجيزه **الحي / المدينة :** العمرانيه **العنوان :** =
رقم البطاقة : 27609010102037 **رقم التليفون :** 01124433763 **تاريخ تسجيل الإستمارة :** 11-10-2026
العمر(تاريخ الميلاد) : 01-09-1976 **المهنة :** ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي **المقر بما فيه**
التوقيع:(----------) **التوقيع:**(----------)

التشخيص الإكلينيكي : لوكيميا
نتائج الأبحاث : (مرفق)
التشخيص النهائي : لوكيميا
خطة العلاج : أورام كيماوي علاج تدعيمي ونقل دم ومشتقاته [6993] **قسم العلاج :** امراض الدم
التعليق على التشخيص : ----------

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/ندى حسن **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/نرمين رمضان **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة و مدير المستشفي.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفي قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

ا.د/ ---------- **ا.د/** ---------- **د/** ---------- **د/** ----------

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : ----------
خطة العلاج : ----------
المستشفي : ----------**قسم :** ----------
جهة العلاج : ----------**نفقات :** ----------
ملاحظات : ----------

رئيس	مدير عام	ختم
المجلس الطبي المتخصص	مديرية الشئون الصحية	شعار الجمهورية

Name: ياسر رجب خلف الله معوض
National ID: 27609010102037

تقرير طبي

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انة

المريض يعاني من لوكيميا ليمفاويه حاده ويحتاج الي Supportive therapy with blood transfusion and blood products.

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين



National ID · Front
[[DOCTYPE:ID_FRONT]]



٢٧٦٠٩٠١٠١٠٢٠٣٧ ٢٠٢٢/٠٢

بدون عمل

ذكر مسلم متزوج

١ البطاقة سارية حتى ٢٠٢٩/٠٢/١٤





National ID - Back
[[DOCTYPE:ID_BACK]]

Name: ياسر رجب خلف الله محمد **MR. :** 4909	

Detailed Medical Report

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من		**بشأن تقرير طبي للمريض**	
بقسم:		**رقم طبي:**	

ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول :		**تاريخ وساعة الخروج :**	

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه

The patient has chronic myeloid leukemia (CML) diagnosed in 2020 and has been receiving treatment since that time. The most recent quantitative polymerase chain reaction performed in October 2025 demonstrated a BCR-ABL transcript level of 0.014 while the patient was on imatinib therapy.

The patient was initially treated with carcemia as first-line therapy for three years beginning in 2021, after which the patient elected to discontinue that regimen. Subsequently, therapy was switched to tasigna, with laboratory monitoring reported as acceptable for tasigna, and BCR-ABL testing was performed in April.

تحريرا في ,

التاريخ :	20-09-2026	**الوقت :**	

الطبيب المعالج : احمد حامد رشاد محمد مسلم

يعتمد ,

Patient Name	: الاستاذ / ياسر رجب خلف الله محوض	Request No.	: 132477
Patient No.	: 27609010102037	Request Date	: 06/09/2021
Path No.	: 1990	Verification Date	: 14/09/2021
Sex	: Male	Financial Category	: اورام دار السلام - نفقة الدولة
Age	: 45 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc :			

Pathology Report

Clinical Data:
? CML.
Nature of the specimen.
B.M.B.
Gross Examination.
3 Bony cores up to 1.5cm long totally submitted.
Microscopic examination:
- Adequate: Yes.
- Cellularity: Hypercellular.
- Myeloid/erythroid ratio: Increased.
- Atypical cells infiltration: Yes.
  - o Focal
  - o Patchy
  - o Interstitial
  - o Diffuse: diffuse infiltrate by meyloid cells.
- Fibrosis: N/A.
- Additional pathologic findings: N/A.

Diagnosis:
Bone marrow biopsy (unilateral).
Hypercellular marrow.
Positive for meyloproliferative disorder for confirmatory marker study.(CD117, CD34, CD3, CD20, Meyloperoxidase).

Prof. Dr. Iman Gouda.
Dr. Enas Mohamed Ali.

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

alfa
L A B S

Collection Date: 27/10/2025
Review Date: 30/10/2025

Referring Doctor: أ.د محمود صلاح

Patient Name: الاستاذ/ باسر رجب خلف الله
Patient No.: 15-40375
Accession No.: 232251011817
Age: 49Y

MOLECULAR BIOLOGY UNIT

BCR-ABL by PCR

Test Name	Result	Reference Interval
BCR-ABL, EDTA	Detected	Not detected

-The test is designed for detection & quantification of BCR-ABL major transcript using Realtime PCR technique.
-Interpretation:
Not detected: no BCR-ABL fusion gene is detected.
Detected: confirms the presence of BCR-ABL fusion gene, supporting the diagnosis of CML.
Below the lower limit of quantification: means that BCR-ABL has been detected at a level <0.0032% (MR >4.52). Follow up is recommended every 3 months until no detectable transcript.

IS%	0.014
MR	3.80

-Quantitative detection of BCR-ABL transcript (Minimal residual disease) help monitor treatment response to tyrosine kinase inhibitors (TKIs) and is expressed as BCR-ABL/ABL ratio (IS%-International Scale & MR-Molecular response).
-IS%: International Scale, is a standardized reporting of BCR-ABL monitoring.
-MR: Molecular response, shows the response of the patient to the targeted treatment.
-IS% is applicable in the range (10% -0.0032%) per 1st WHO international genetic reference panel for the quantification of BCR-ABL transcript (a higher ratio indicates a higher disease burden, & a lower ratio suggests a good response to treatment).

Reviewed By:

PL Branch: فرعPL8(كابر طهرموس)

Printed by: محمد صبحي محمد36790

AMG ALFA MEDICAL GROUP
A MEMBER OF ALFA MEDICAL GROUP
معامل الفا
16191
Lab Test
[[DOCTYPE:LAB_TEST]]

Patient Name	: الاستاذ / ياسر رجب خلف الله معوض	Request No.	: 132477
Patient No.	: 27609010102037	Request Date	: 06/09/2021
Path No.	: 1990	Verification Date	: 14/09/2021
Sex	: Male	Financial Category	: اورام دار السلام - نفقة الدولة
Age	: 45 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc :			

Pathology Report

Clinical Data:
? CML.
Nature of the speciment:
B.M.B.
Gross Examination:
3 Bony cores up to 1.5cm long totally submitted.
Microscopic examination:
- Adequate: Yes.
- Cellularity: Hypercellular.
- Myeloid/erythroid ratio: Increased.
- Atypical cells infiltration: Yes.
  - o Focal
  - o Patchy
  - o Interstitial
  - o Diffuse: diffuse infiltrate by meyloid cells.
- Fibrosis: N/A.
- Additional pathologic findings: N/A.

Diagnosis:
Bone marrow biopsy (unilateral).
Hypercellular marrow.
Positive for meyloproliferative disorder for confirmatory marker study.(CD117, CD34, CD3, CD20, Meyloperoxidase).

Prof. Dr. Iman Gouda.
Dr. Enas Mohamed Ali.

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

alfa
L A B S

Collection Date: 27/10/2025
Review Date: 30/10/2025

Referring Doctor: أ.د محمود صلاح

Patient Name: الاستاذ/ ياسر رجب خلف الله
Patient No.: 15-40375
Accession No.: 232251011817
Age: 49Y

MOLECULAR BIOLOGY UNIT

BCR-ABL by PCR

Test Name	Result	Reference Interval
BCR-ABL, EDTA	**Detected**	Not detected

-The test is designed for detection & quantification of BCR-ABL major transcript using Realtime PCR technique.
-Interpretation:
Not detected: no BCR-ABL fusion gene is detected.
Detected: confirms the presence of BCR-ABL fusion gene, supporting the diagnosis of CML.
Below the lower limit of quantification: means that BCR-ABL has been detected at a level <0.0032% (MR >4.52). Follow up is recommended every 3 months until no detectable transcript.

IS%	**0.014**	
MR	**3.80**	

-Quantitative detection of BCR-ABL transcript (Minimal residual disease) help monitor treatment response to tyrosine kinase inhibitors (TKIs) and is expressed as BCR-ABL/ABL ratio (IS%-International Scale & MR-Molecular response).
-IS%: International Scale, is a standardized reporting of BCR-ABL monitoring.
-MR: Molecular response, shows the response of the patient to the targeted treatment.
-IS% is applicable in the range (10% -0.0032%) per 1st WHO international genetic reference panel for the quantification of BCR-ABL transcript (a higher ratio indicates a higher disease burden, & a lower ratio suggests a good response to treatment).

Reviewed By:

Pt. Branch: فيصل8(كفر طهرموس)

Printed by: محمد صبحي محمد36790

AMG A MEMBER OF ALFA MEDICAL GROUP
معامل الفا
16191
[[DOCTYPE:LAB_TEST]]

Patient Name	: الاستاذ / ياسر رجب خلف الله معوض	Request No.	: 132477
Patient No.	: 27609010102037	Request Date	: 06/09/2021
Path No.	: 1990	Verification Date	: 14/09/2021
Sex	: Male	Financial Category	: اورام دار السلام - نفقة الدولة
Age	: 45 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc :			

Pathology Report

Clinical Data:
? CML.
Nature of the speciment:
B.M.B.
Gross Examination:
3 Bony cores up to 1.5cm long totally submitted.
Microscopic examination:
- Adequate: Yes.
- Cellularity: Hypercellular.
- Myeloid/erythroid ratio: Increased.
- Atypical cells infiltration: Yes.
  - o Focal
  - o Patchy
  - o Interstitial
  - o Diffuse: diffuse infiltrate by meyloid cells.
- Fibrosis: N/A.
- Additional pathologic findings: N/A.

Diagnosis:
Bone marrow biopsy (unilateral).
Hypercellular marrow.
Positive for meyloproliferative disorder for confirmatory marker study.(CD117, CD34, CD3, CD20, Meyloperoxidase).

Prof. Dr. Iman Gouda.
Dr. Enas Mohamed Ali.

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

alfa
L A B S

Collection Date: 27/10/2025
Review Date: 30/10/2025

Referring Doctor: أ.د محمود صلاح

Patient Name: الاستاذ/ ياسر رجب خلف الله
Patient No.: 15-40375
Accession No.: 232251011817
Age: 49Y

MOLECULAR BIOLOGY UNIT

BCR-ABL by PCR

Test Name	Result	Reference Interval
BCR-ABL, EDTA	**Detected**	Not detected

-The test is designed for detection & quantification of BCR-ABL major transcript using Realtime PCR technique.
-Interpretation:
Not detected: no BCR-ABL fusion gene is detected.
Detected: confirms the presence of BCR-ABL fusion gene, supporting the diagnosis of CML.
Below the lower limit of quantification: means that BCR-ABL has been detected at a level <0.0032% (MR >4.52). Follow up is recommended every 3 months until no detectable transcript.

IS%	**0.014**	
MR	**3.80**	

-Quantitative detection of BCR-ABL transcript (Minimal residual disease) help monitor treatment response to tyrosine kinase inhibitors (TKIs) and is expressed as BCR-ABL/ABL ratio (IS%-International Scale & MR-Molecular response).
-IS%: International Scale, is a standardized reporting of BCR-ABL monitoring.
-MR: Molecular response, shows the response of the patient to the targeted treatment.
-IS% is applicable in the range (10% -0.0032%) per 1st WHO international genetic reference panel for the quantification of BCR-ABL transcript (a higher ratio indicates a higher disease burden, & a lower ratio suggests a good response to treatment).

Reviewed By:

Pt. Branch: فيصل8(كفر طهرموس)

Printed by: محمد صبحي محمد36790

AMG A MEMBER OF ALFA MEDICAL GROUP
معامل الفا
16191
[[DOCTYPE:LAB_TEST]]

[[DOCTYPE:NON_UHIA_LETTER]]
Non-UHIA Letter

إسم المريض ثلاثي: ياسر رجب خليل ال...

رقم الملف: .....

تقريـر طبـي

السيد/.....

تحية طيبة وبعد،،

ايماء للطلب المقدم من ..... بشان تقرير طبي للمريض: ياسر رجب خليل ال...

بقسم.....رقم طبي .....

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته :

تاريخ وساعة الدخول.....تاريخ وساعة الخروج.....

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه:

المريض يأخذ سر لتكيسا جلايفك مرفقة والمريض يتابع ...
بصورة ... (imatinib) بجرعة ... مرة يومياً ...
فترة ... شهر مع إجراء الفحوصات والأشعة ...

تحريرا في

الوقت: ..... التاريخ : ١١/١٠/٢٠٢٦

الطيب المعالج

.....

يعتمد ،،